

통 보

제 목 간호관리료 차등제 등급 운영·관리에 관한 사항

소 관 기 관 ■■■■■병원

조 치 기 관 ■■■■■병원

내 용

1. 업무개요

■■■■■병원은 환자의 상태 및 간호 요구도에 따라 일반병동, 간호·간병통합서비스 병동, 중환자실, 호스피스 완화병동을 운영하고 있으며, 원내 병동별 병상수 및 배치된 간호인력은 [표 1]과 같다.

[표 1] ■■■■■병원 병상 운영 현황('26.2.28.기준)

구 분	일반병동	간호간병병동	중환자실	호스피스 완화병동	합 계
병상 수 (실 운영병상 수)					
간호사 수					

※ ■■■■■병원 제출 사전요구자료 각색

2. 관계법령 및 판단기준

「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제5조 및 [별표 1]에 따라 의료기관은 병동 종류별로 간호인력을 적정하게 배치해야 하며, 이에 따른 간호인력 확보 수준¹⁾(직전 분기 평균 환자 수 대비 해당 병동에서 간호업무에 종사하는 직전 분기 평균 간호사 수)을 기준으로 분기별 간호관리료 차등제 등급 수가를 다르게 적용하며, 일반병동 및 중환자실의 차등제 등급 산정 기준은 [표 2]와 같다.

1) 2024.1.1. 이전까지 운영병상 수 대비 간호사수로 차등제 등급을 산정하였으나 2024.1.1. 이후 부터는 환자수 대비 간호사수로 변경하여 간호관리료 차등제 등급 산정함

[표 2] 종합병원 간호관리료 차등제 등급 산정 기준

구분	등급 기준	등급별 입원료 가감수준
일반병동	S등급 : 1.5:1 미만인 경우 A등급 : 2.0:1 미만 1.5:1 이상인 경우 1등급 : 2.5:1 미만 2.0:1 이상인 경우 2등급 : 3.0:1 미만 2.5:1 이상인 경우 3등급 : 4.0:1 미만 3.0:1 이상인 경우 4등급 : 6.0:1 미만 4.0:1 이상인 경우 5등급 : 6.0:1 이상인 경우	S등급 : A등급 입원료 소정점수의 12% 가산 A등급 : 1등급 입원료 소정점수의 12% 가산 1등급 : 입원료 소정점수로 산정 2등급 : 1등급 입원료 소정점수의 10% 감산 3등급 : 2등급 입원료 소정점수의 10% 감산 4등급 : 3등급 입원료 소정점수의 10% 감산 5등급 : 4등급 입원료 소정점수의 30% 감산 (광역시 구지역 소재 의료기관 기준)
중환자실	S등급 : 0.23:1 미만인 경우 A등급 : 0.33:1 미만 0.23:1 이상인 경우 1등급 : 0.43:1 미만 0.33:1 이상인 경우 2등급 : 0.53:1 미만 0.43:1 이상인 경우 3등급 : 0.63:1 미만 0.53:1 이상인 경우 4등급 : 0.83:1 미만 0.63:1 이상인 경우 5등급 : 1.25:1 미만 0.83:1 이상인 경우 6등급 : 1.67:1 미만 1.25:1 이상인 경우 7등급 : 1.67:1 이상인 경우	S등급 : A등급 입원료 소정점수의 20% 가산 A등급 : 1등급 입원료 소정점수의 20% 가산 1등급 : 2등급 입원료 소정점수의 20% 가산 2등급 : 3등급 입원료 소정점수의 20% 가산 3등급 : 일반 중환자실 입원료 소정점수로 산정 4등급 : 3등급 입원료 소정점수의 20% 감산 5등급 : 4등급 입원료 소정점수의 20% 감산 6등급 : 5등급 입원료 소정점수의 20% 감산 7등급 : 6등급 입원료 소정점수의 20% 감산

※ 건강보험 요양급여 비용 발체

따라서, ■■■■■병원에서는 병상가동률에 따른 간호사 인력배치 등을 점검하여 병원 수익 증대가 이루어질 수 있도록 간호인력 차등제 등급 향상을 위한 인력배치에 대해 고려하여 간호인력을 운영하여야 할 것이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■병원의 건강보험심사평가원에서 통보된 2024~2025년도 중환자실 및 일반병동의 간호관리료 차등제 등급을 확인해 본 결과, 중환자실의 경우 [표 3]과 같이 2024년 1분기 *등급 적용 이후 2024년 2·3분기 *등급 적용 이후 *등급을 유지하고 있는 것으로 확인된다.

[표 3] 중환자실 간호관리료 차등제 산정현황

분 기		등 급	비율 (환자÷간호사)	환자수 (명/일)	간호사수 (명/일)	비 고
2024년	1분기					
	2분기					
	3분기					
	4분기					
2025년	1분기					
	2분기					
	3분기					
	4분기					

※ 심평원 중환자실 차등제 통보내역 발체

또한, 동일 기간 국민건강보험공단이 ■■■■■ 병원에 통보한 간호·간병통합 서비스 병동 제공인력 배치 현황을 확인한 결과, 환자 수 감소에 따라 간호사 배치 수준이 신고 기준(1:8)보다 낮은 비율로 운영되었고, ([표 4] 참고) 일반병동 역시 동일한 사유로 환자 대 간호사 비율이 낮게 유지되어 차등제 등급이 상향 되어 운영된 것으로 확인된다. ([표 5] 참고)

[표 4] 간호·간병통합서비스 병동 제공인력 배치 현황

(단위 : 명)

분 기		환자수	간호사(1:8 배치 기준)			
			적용인원(A)	배치수준*	1:8 필요인원(B)	초과배치인원(A-B)
2023년 4분기						
2024년	1분기					
	2분기					
	3분기					
	4분기					
2025년	1분기					
	2분기					
	3분기					

※ 국민건강보험공단 간호·간병통합서비스 제공인력 배치 통보내역 재가공

*배치수준 계산식: 환자수(일평균) × 4.8 ÷ 간호사 적용인원(일평균) [소수 1자리 반올림]

[표 5] 일반병동 간호관리료 차등제 산정현황(심평원 통보 기준)

(단위 : 명)

분 기		간호등급	간호사수(A)	환자수(B)	비율(B/A)	1등급 필요(C)	초과배치(A-C)
2 0 2 4 년	1분기						
	2분기						
	3분기						
	4분기						
2 0 2 5 년	1분기						
	2분기						
	3분기						
	4분기						

※ 심평원 중환자실 간호인력 차등제 통보내역 재가공

따라서 ■■■■■병원은 장기화되는 재원 환자 감소 상황을 고려하여 간호인력 운영의 효율성을 제고할 필요가 있다.

간호인력 차등제등급 상향 시 입원료수가 인상으로 병원수익에 기여하는 일반병동, 중환자실과는 달리, 간호·간병통합서비스 병동은 국민건강보험공단에 운영신고 기준(1:8)보다 간호사 인력을 여유 있게 배치하더라도 추가적인 수가 보상이 발생하지 않으므로, 중환자실의 간호인력 차등제 등급 하락 상황 등을 고려 시 병원의 수익성에 영향이 없는 간호·간병통합서비스 병동의 인력을 중환자실로 탄력적 전환 배치하는 방안 등에 간호인력의 효율적 배치운영에 대해 검토할 필요성이 있다.

관계기관 의견

■■■■■■■병원 간호실은 간호인력 차등제 등급 변동 및 간호인력 운영과 관련하여 다음과 같은 의견을 제시하였다.

중환자실의 간호인력 차등제등급 상향은 재원 환자 감소에 따른 가동률 저하(64%)와 운영 효율성을 위한 선제적 병상 축소(13→11병상) 과정에서 나타난 결과이며, 간호·간병통합서비스 병동의 인력은 지정기준(1:8)을 준수하기 위한 필수 배치이므로, 가동률의 일시적 저하로 간호사를 타 병동으로 재배치할 수 없으며,

일반병동 간호인력 또한 3교대 유지를 위한 최소 인원이며, 보건복지부의 ‘교대제 개선 시범사업’ 참여로 인해 수시 인력 재배치가 제도적으로 제한되어 있고, 중환자실과 일반병동에서 요구되는 간호 역량이 각기 다르기 때문에 단순히 등급 향상을 위해 인력을 즉각 전환하는 것은 현장 여건상 무리이며, 일반병동의 등급 상향 역시 재원 환자 감소로 인해 환자 대 간호사 비율이 자연스럽게 낮아지면서 발생한 것이라는 의견을 제출하였다.

그러나, 이러한 ■■■■■병원의 의견은 다음과 같은 이유로 타당성이 부족하다.

중환자실의 경우 2024.1.1.부터 건강보험심사평가원의 차등제 등급 산정 기준이 신고(운영)병상 수에서 재원 환자 수로 변경되었으므로 단순히 운영 병상을 축소할 것을 간호인력 배치의 효율성과 연결 짓는 것은 무리가 있고,

간호·간병통합서비스 병동의 가동률 저하가 일시적이라는 주장과 달리, 실제로는 2024년 3분기부터 재원환자 수 감소가 장기화되고 있는 상황으로 ■■■■병원의 입원료 수익에 추가적인 영향을 주지 않는 간호·간병통합서비스 병동의 간호인력 배치를 재검토하거나, 원내 병상가동률 향상을 위한 진료과와 운영진 차원의 종합적인 대책 마련이 필요한 상황으로 판단된다.

조치할 사항

■■■■병원장은

병동 간 간호인력 배치의 적정성을 확보하여 간호등급을 유지·개선할 수 있도록, 병상가동률 향상 및 간호인력 재배치를 포함한 전반적인 병원 운영 개선 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)